

Tireoide · hipo, hipertireoidismo e tormenta

Interprete sempre TSH + T4L no contexto clínico. Distinga tireotoxicose por hipertireoidismo verdadeiro de destruição glandular — a conduta com antitireoidiano muda.

Basedow × tireoidite

Lembre - Basedow × tireoidite

Basedow: TRAb+, captação alta, oftalmopatia possível !' metimazol/PTU. Tireoidite: captação baixa, fase destrutiva !' betabloqueador e suporte; antitireoidiano não ajuda.

Triagem de prova: sintomas + TSH/T4L definem via; emergências exigem suporte e hormônio/bloqueio imediato.

Síndromes tireoidianas

Hipo / hiper / emergencia

Hipotireoidismo

TSH alto, T4L baixo
Levotiroxina
Cuidado em idoso/CAD

Hashimoto comum

Hipertireoidismo

TSH baixo, T4L alto
ATD +/- betabloqueador
Cintilo se duvida

Basedow / nódulo

Emergencia

Tormenta tireotóxica
Coma mixedematoso
UTI + protocolo

Alta mortalidade

Tormenta tireotóxica — pilares

- Suporte: ABC, resfriamento, volume, tratar precipitante (infecção, cirurgia)
- Betabloqueador (propranolol) para sintomas adrenérgicos
- Tionamida (PTU preferido na gravidez 1ºT / tormenta por inibir conversão) + iodo após ATD
- Corticoide para bloquear conversão T4!T3 e insuficiência adrenal relativa

Achados laboratoriais

Condição | Padrão típico

Hipo primário | TSH !', T4L !"

Hiper primário | TSH !", T4L !' (± T3 !')

Hipo central | TSH baixo/inadequado + T4L !"

Tiroxina excesso | TSH !"; diferenciar exógena × endógena

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

No coma mixedematoso: aquecer passivamente, hidrocortisona antes/junto da levotiroxina (pode haver insuficiência adrenal associada) e tratar precipitante. Não atrase hormônio esperando 'todos os exames'.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Tempestade tireotóxica e coma mixedematoso são emergências com critérios clínicos e suporte intensivo.

Diagnóstico clínico: hipertermia, taquicardia, SNC, GI/hepático + fator precipitante.

Tempestade tireotóxica (Burch-Wartofsky ideia)

Pontuação clínica

Temperatura (até 30 pts)	var
SNC (agitação a coma)	var
GI/hepático (diarreia a icterícia)	var
Taquicardia / ICC / FA	var
Fator precipitante	var

>=45: tempestade provável | 25-44: iminente | <25: improvável

Hipotermia + rebaixamento + precipitante em hipotireoidismo grave.

Mixedema / coma mixedematoso

Emergência hipotiroídiana

- 1 Hipotermia
- 2 Alteração mental / coma
- 3 Bradcardia / hipoventilação / hipoNa
- 4 Precipitante (infecção, frio, sedativo)

Tratar antes de confirmar labs se alta suspeita

Ordem do tratamento na tempestade

Passo | Droga

- 1 — bloqueio periférico | Betabloqueador (propranolol)
- 2 — síntese | PTU (ou metimazol) — PTU também bloqueia T4! T3
- 3 — bloqueio de liberação | Iodo (Lugol/SSKI) "e1 h após tionamida
- 4 — suporte | Corticoide (bloqueia conversão) + UTI + tratar precipitante

Mixedema — conduta

- T4 IV ($\pm$ T3 em protocolos) com cuidado cardíaco
- Hidrocortisona empírico (possível insuficiência adrenal associada)
- Aquecimento passivo, suporte ventilatório, ATB se infecção
- Corrigir hiponatremia com cautela

Labs

Lembre - Labs

Tempestade: TSH!“, T4/T3!‘ (mas gravidade é clínica). Mixedema: TSH!‘ (primário) com T4!“; cortisol pode estar baixo.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1